

Ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique
Université 3Constantine Salah Boubnider .
Faculté de médecine CHU Constantine.
Laboratoire d'Anatomie générale.
Cours pour étudiants de la deuxième année de médecine
Fait par DR BOUSBA Maitre Assistante,
2023 /2024

Le jéjuno –iléon

I-Introduction :

Le jéjuno –iléon (les anses grêles) est la portion mobile de l'intestin grêle qui fait suite à sa portion fixe , le duodénum .Il s'étend de l'angle duodéno-jéjunal à la jonction iléo-caecale . Se termine dans le caecum par la valvule iléo-caecale .

II-Anatomie descriptive :

Dimensions :

Longueur : environ 6,5 mètres

Calibre 3cm à l'angle duodéno-jéjunal ,2cm à sa terminaison.

Configuration externe :

De couleur rosée, long tube irrégulièrement cylindrique situé dans l'étage sous mésocolique il décrit une série de longues flexuosités très mobiles ,15 à 16 appelés anses intestinales . Chacune d'elles a la forme d'un U dont les branches plus au moins parallèles sont en contact l'une avec l'autre.

Deux groupes d'anses intestinaux :

---**un groupe supérieur** formé d'anses horizontales, placées les unes au dessous des autres , dans la partie médiane et gauche de l'abdomen, elles forment le jéjunum (jeuner ;sont vide à jeun)

--- **un groupe inférieur** formé d'anses verticales les unes à coté des autres et d'avant en arrière elles forment l'iléon ou iléum (s'enrouler)

Les 15 derniers centimètres sont ascendants jusqu'à leur implantation dans le caecum.

Le diverticule de Meckel ,on observe chez 2% des sujet un reliquat du canal omphalo-mésentérique : un petit diverticule en doigt de gant de 5à 6 cm de long qui siège sur l'iléon à environ 80 cm du caecum, peut être l'origine d'accident inflammatoire et hémorragique..

Chaque anse intestinale présente :

--deux faces convexes, en contact avec les anses voisines

--un bord libre convexe :en rapport avec la paroi abdominale antérieure et avec les anses attenantes

--un bord adhérent : concave le long duquel le péritoine de l'intestin se continue avec les deux feuillets du mésentère.

Constitution :la paroi du jéjuno-iléon est constitué de la superficie à la profondeur par quatre tuniques :

1-la séreuse : péritonéale transparente accolée à la couche sous-jacente .se continue le long du bord adhérent des anses avec les deux feuillets du mésentère.

2-La musculuse longitudinale superficielle, circulaire profonde.

3-la sous muqueuse : lâche

4-La muqueuse : rosée présente trois sortes de reliefs

--villosités intestinales donnent à la muqueuse un aspect velouté.

---valvules conniventes ou replis circulaires nombreux dans la partie haute, absents dans la portion terminale.

---les plaques de Peyer : amas de follicules clos lymphoïdes surtout dans la partie basse.

III-Fixité et mésentère

---Par ses deux extrémités: angles duodéno-jéjunal et iléo-caecal.

-- à la paroi abdominale postérieure par un long méso péritonéal **le mésentère** (organe de soutien et de nutrition).

le mésentère formé de deux lames péritonéales , a la forme d'un éventail présente :

--Deux faces :antérieure et postérieure .

--Un bord libre se confond avec les anses intestinales.

--Un bord adhérent à la paroi postérieure c'est la racine du mésentère depuis l'angle duodéno-jéjunale à la jonction iléo-caecale .

Il permet le passage des vaisseaux mésentériques.

Il contient noyés dans la graisse, l'artère et la veine mésentériques supérieures, les nœuds et vaisseaux lymphatiques mésentériques supérieures et les rameaux nerveux du plexus mésentérique supérieur.

IV-Rapports :

les anses forment une masse qui remplit dans la cavité abdomino-pelvienne un large espace, plus étendu à gauche qu'à droite qui répond ;

En avant : le grand omentum et la paroi abdominale antérieure.

En arrière :la paroi abdominale postérieure ,

la région rétro péritonéale et son contenu ::l'aorte et veine cave inférieure , la partie inférieure du bloc duodéno-pancréatique, reins et uretères).

les méso colons droit et gauche et colon descendant.

En haut : au colon transverse et son méso qui les sépare des organes sus méso coliques.

En bas : au colon ilio-pelvien et aux organes pelviens rectum et vessie chez l'homme, rectum, vessie, utérus et ligaments larges chez la femme.

A gauche : la paroi latérale de l'abdomen, colon descendant.

A droite :aux caecum ,colon ascendant et la paroi latérale de l'abdomen.

V- VAISSEAUX ET NERFS :

-Artères :les branches intestinales de l'artère mésentérique supérieure et descendent dans le mésentère .

Ces artères s'anastomosent entre elles, dessinant des arcades vasculaires

Des arcades juxta -intestinales, naissent les artères droites .Chaque artère droite se divise en deux rameaux pour chacune des faces de l'intestin .Ces rameaux peuvent s'anastomoser mais souvent de type terminal expliquant certains nécroses intestinales à l'emporte pièce en cas d'oblitération.

Veines : naissent d'arcades veineuses intestinales superposables aux arcades artérielles, se jettent dans la veine mésentérique supérieure (veine porte).

Les lymphatiques : vont directement aux éléments du groupe juxta-intestinal,

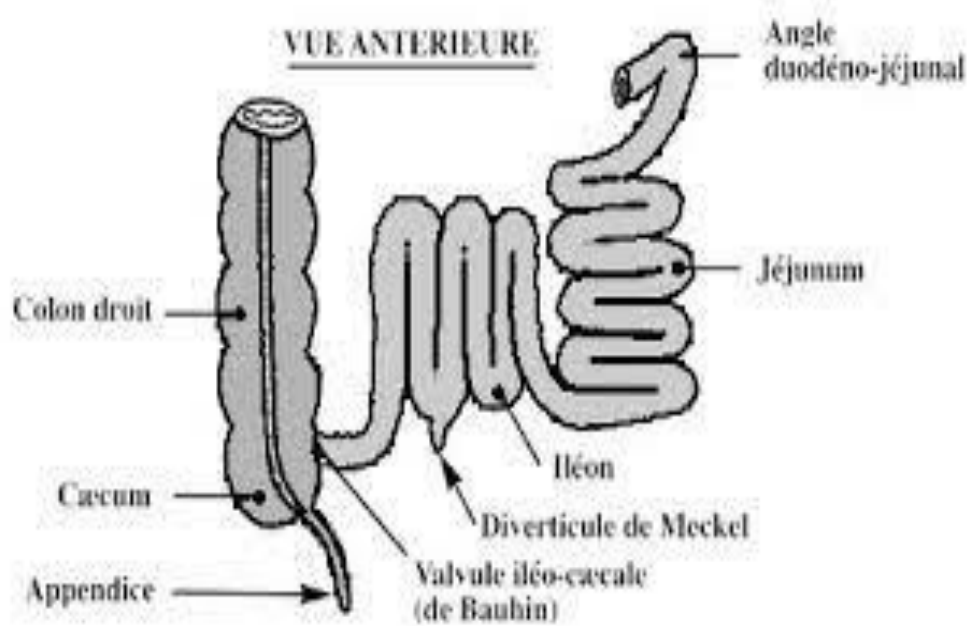
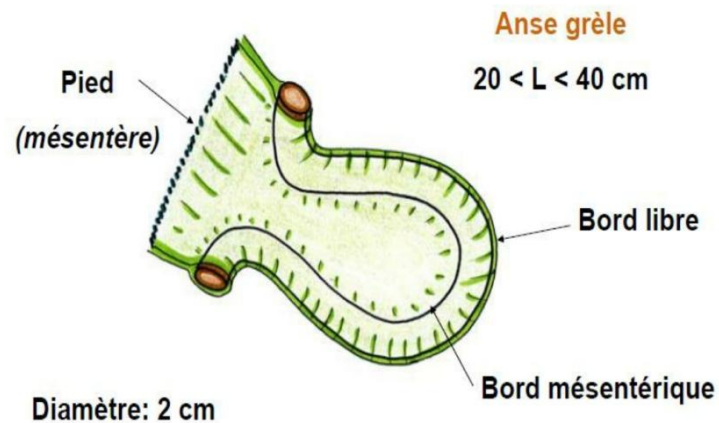
Les lymphonœuds centraux situés dans le mésentère drainent les lymphonœuds juxta intestinaux et se terminent dans les nœuds mésentériques supérieurs

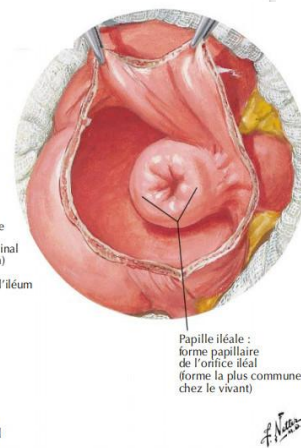
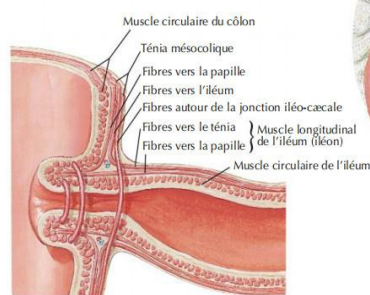
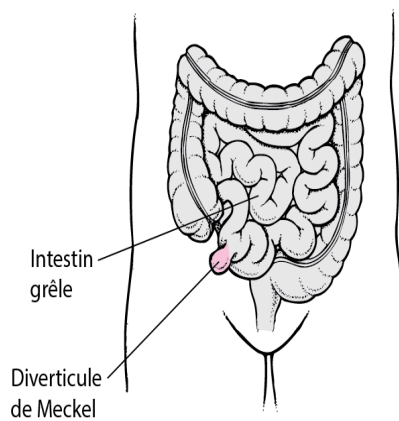
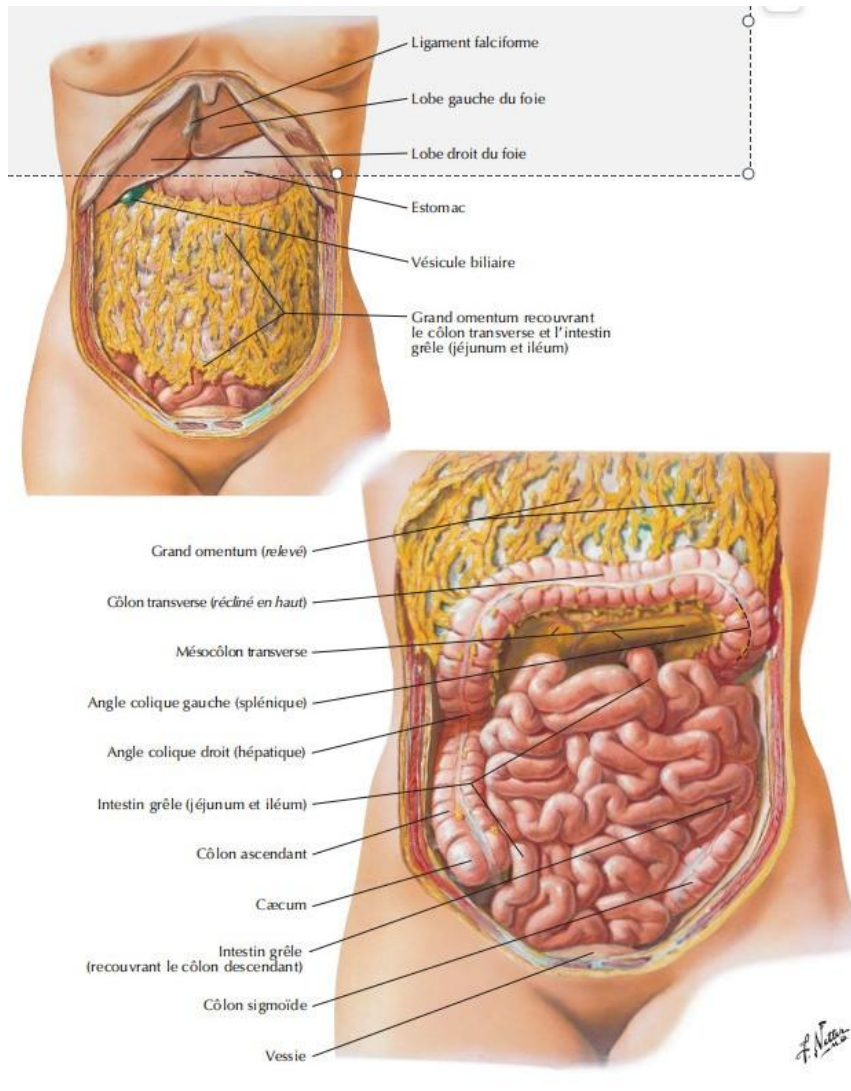
à partir de ces nœuds les troncs lymphatiques se jettent la citerne du chyle .

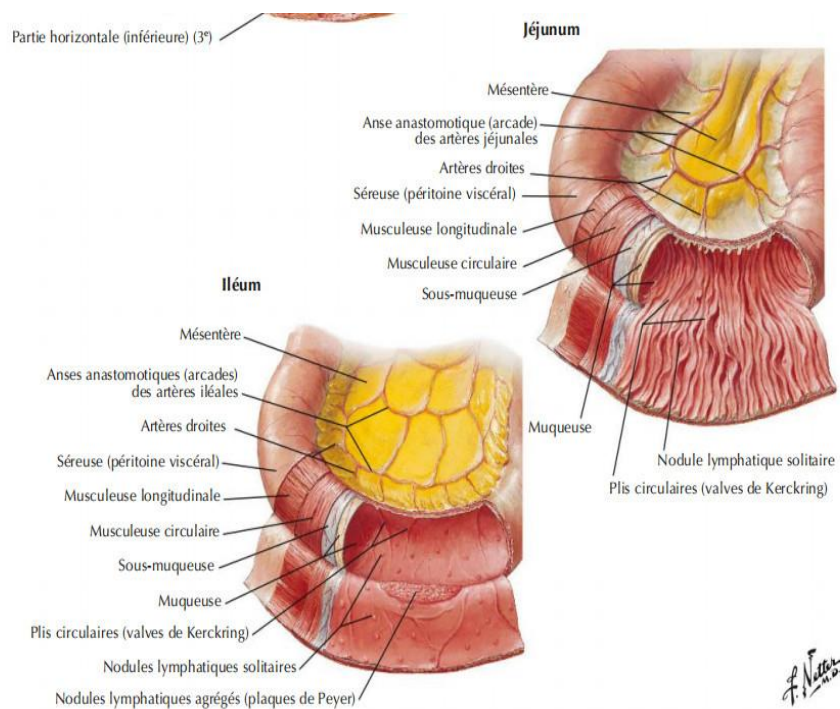
Les nerfs / plexus mésentérique supérieur formé par les neurofibres sympathiques et para sympathiques.

-----FIN-----

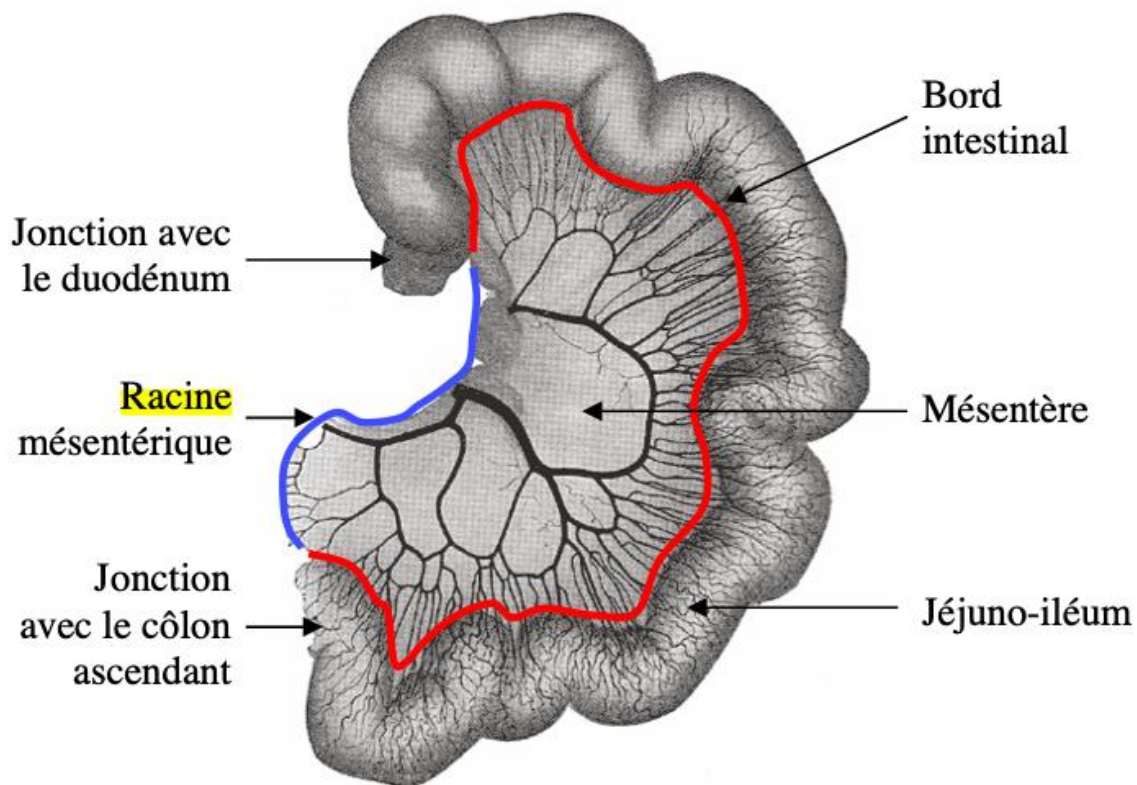
Références : -A Bouchet anatomie 4 abdomen region rétropéritonéale
H Rouvière anatomie du tronc tome 2 tronc
Hammoudi Si salah anatomie appareil digestif
P Kamina abdomen



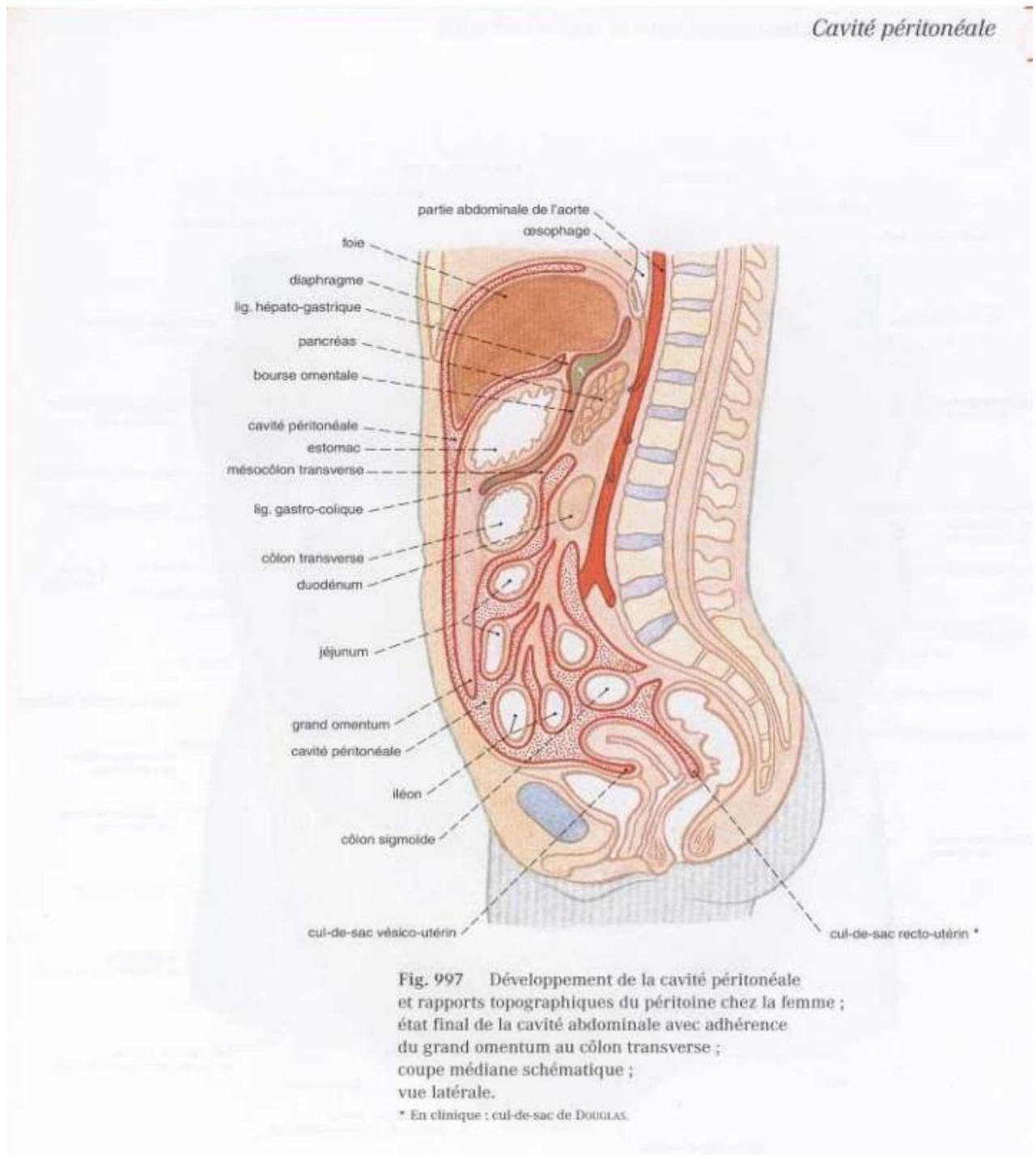




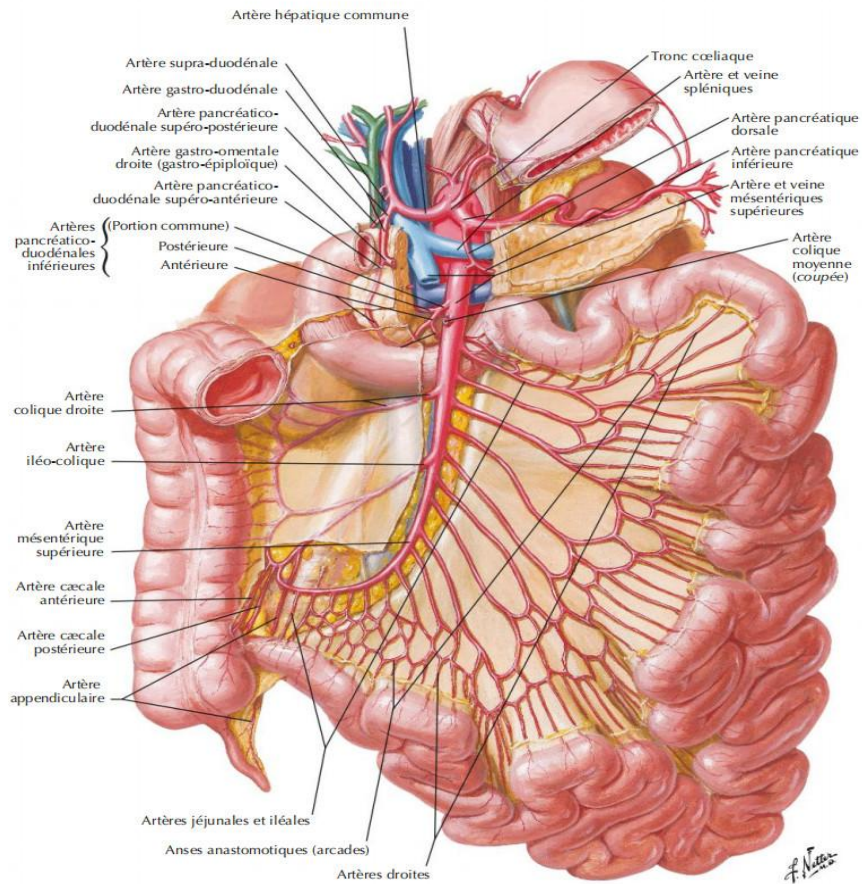
Constitution de la paroi jéjuno-iléale



Le mésentère



Artères de l'intestin grêle



Veines de l'intestin grêle

